

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re CTI

Lutte contre les accidents cardiovasculaires

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue votre capacité à analyser des situations cliniques, interpréter des paramètres physiologiques et proposer des mesures de prévention adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Fonctionnement et pathologie coronaire

Un patient de 52 ans, résidant à Douala, consulte pour une douleur thoracique brutale survenant au repos, irradiant vers le bras gauche et la mâchoire, non cédant au repos. L'ECG montre une sus-décalage du segment ST dans les dérivations antérieures. La coronarographie réalisée en urgence met en évidence une sténose sévère (90 %) de l'artère interventriculaire antérieure.

1. Rappeler le rôle des artères coronaires dans la vascularisation du myocarde.
2. Expliquer le mécanisme physiopathologique reliant la sténose coronaire observée à la survenue de l'infarctus du myocarde (nécrose myocardique).
3. Justifier pourquoi la douleur survient au repos chez ce patient, alors qu'elle est classiquement déclenchée par l'effort dans l'angine de poitrine stable.

EXERCICE 2 Facteurs de risque et profil épidémiologique camerounais

Une enquête transversale menée dans un arrondissement de Yaoundé auprès de 400 adultes de 40 à 60 ans a recueilli les données suivantes :

Profil	Hypertension artérielle (HTA)	Diabète	Tabagisme actif	Sédentarité (< 150 min/sem)
Hommes (n=180)	42%	18%	25%	55%
Femmes (n=220)	38%	22%	5%	68%

1. Calculer le nombre absolu d'hommes et de femmes présentant une HTA dans cet échantillon.
2. Identifier, en vous basant sur le tableau, les deux facteurs de risque cardiovasculaire les plus prévalents dans cette population globale.
3. Un homme de 50 ans, fumeur, sédentaire et hypertendu non traité consulte. Citer quatre facteurs de risque majeurs qu'il cumule et expliquer pourquoi leur association potentialise le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique.

EXERCICE 3 Interprétation de la tension artérielle et conduite à tenir

Lors d'une campagne de dépistage dans une entreprise de Kribi, trois mesures de tension artérielle (TA) sont effectuées à 2 minutes d'intervalle chez trois employés au repos, position assise. Les moyennes obtenues sont :

- Employé A (35 ans) : 138 mmHg / 88 mmHg
- Employé B (48 ans, diabétique) : 148 mmHg / 92 mmHg
- Employé C (55 ans) : 162 mmHg / 102 mmHg

1. Classer la TA de chaque employé selon la classification OMS/ISH (Normale, Normale haute, HTA Grade 1, Grade 2, Grade 3).
2. Pour l'employé B, justifier la prise en charge spécifique recommandée dès le Grade 1 en raison de sa comorbidité.
3. Proposer trois mesures hygiéno-diététiques prioritaires, applicables localement (aliments disponibles au Cameroun), à prescrire à l'employé C en attendant la consultation médicale.

EXERCICE 4 Prévention secondaire et réadaptation post-AVC

Monsieur K., 60 ans, ancien cadre bancaire à Bafoussam, a survécu à un AVC ischémique hémisphérique gauche il y a 3 mois. Il présente une hémiplégie droite modérée et une dysarthrie. Il est traité par antiagrégants plaquettaires, statine et antihypertenseur. Son bilan lipidique actuel montre un LDL-cholestérol à $1,8 \text{ g L}^{-1}$ (cible $< 1,4 \text{ g L}^{-1}$) et une HbA1c à 6,8%.

1. Définir la prévention secondaire dans le contexte des accidents cardiovasculaires.
2. Analyser le bilan biologique de Monsieur K. : les objectifs thérapeutiques sont-ils atteints ? Quels risques résiduels persistent ?
3. Concevoir un programme hebdomadaire d'activité physique adaptée (type, fréquence, durée, intensité) pour ce patient hémiparétique, en précisant les précautions à respecter.

EXERCICE 5 Alimentation traditionnelle et risque cardiovasculaire

Le tableau ci-dessous compare la composition nutritionnelle moyenne pour 100 g de trois plats traditionnels consommés à midi dans une cantine universitaire de Dschang.

Plat	Lipides (g)	Glucides
Ndolé (feuilles, arachide, viande fumée, huile rouge)	28	15
Riz sauce tomate/poisson sec (huile rouge)	12	45
Pâte de maïs (corn flour) + Sauce okok (feuilles, arachide, poisson, peu d'huile)	10	50

Les apports journaliers recommandés (AJR) pour un adulte sont : Lipides < 30% AET, Glucides 50–55% AET, Sodium < 2000 mg (5 g sel).

1. Identifier le plat le plus athérogène et le plus hypertensigène. Justifier votre choix en vous référant aux seuils nutritionnels.
2. Calculer l'apport en sodium (en mg) apporté par une portion de 300 g de Ndolé. Quel pourcentage de l'AJR sodium cela représente-t-il ?
3. Proposer deux modifications culinaires concrètes pour la recette du Ndolé afin de réduire significativement sa teneur en lipides saturés et en sodium, sans en dénaturer le goût.